

· 临床用药 ·

硝酸异山梨醇酯的药物相互作用

大连医学院附属第一医院药剂科 徐永昭

硝酸异山梨醇酯是一种新型抗心绞痛、抗心力衰竭的硝酸酯类化合物。疗效好，毒副作用少，在临床上应用广泛。现将其药物相互作用综述如下，供参考。

1. 硝酸异山梨醇酯与地戈辛

硝酸异山梨醇酯能增加肾小管对地戈辛的排泄，使血清地戈辛浓度下降50%左右，故二者合用时，应适当的增加地戈辛的剂量，以保证地戈辛的治疗作用〔1〕。

2. 硝酸异山梨醇酯与多巴胺

硝酸异山梨醇酯能使血管扩张，降低心脏负荷。多巴胺能加强心肌的收缩力。二者合用时，对心肌梗塞具有良好的疗效。

3. 硝酸异山梨醇酯与多巴酚丁胺

多巴酚丁胺能减少心力衰竭时的心肌损害，增加心输出量，降低肺嵌压。当与硝酸异山梨醇酯合用时，对治疗充血性心力衰竭具有良好的协同作用。心律不齐消失，对心率和血压影响很小，病人耐受良好〔1〕。

4. 硝酸异山梨醇酯与吡丁醇

吡丁醇兼有正性收缩和扩血管作用，能使心脏指数增加，肺嵌压下降，全身血管阻力下降。如与硝酸异山梨醇酯合用时，能使充盈压下降的更明显。

5. 硝酸异山梨醇酯与氨利酮

氨利酮具有强大的正性收缩作用，增加射血比数和心排血量，降低左室充盈压及外周血管阻力，增加肾血流量及肾小球滤过率。但有人报道，剂量不足时，可出现血管效应，如与硝酸异山梨醇酯合用时，可克服这一现象，并能取得良好的治疗效果〔2〕。

6. 硝酸异山梨醇酯与硝酸甘油

二者均属硝酸酯类药物，存有交叉耐药性，长期使用硝酸异山梨醇酯后，再给予硝酸甘油，单剂量可能无效。

7. 硝酸异山梨醇酯和心得安

二者具有协同的抗心绞痛作用，并能相互拮抗毒副作用，使疗效增加。如心得安可拮抗硝酸异山梨醇酯引起的心动过速，而硝酸异山梨醇酯则能纠

正心得安引起的心脏扩大的倾向。故多数学者认为，二者合用治疗心绞痛有良好疗效〔3〕。

8. 硝酸异山梨醇酯与美多心安

有人报道，二者合用对心绞痛的治疗效果不佳，未能降低心绞痛发作的次数，也没能减少硝酸酯类药物的用量〔4〕。

9. 硝酸异山梨醇酯与泰羟心安

二者具有协同的抗心绞痛作用，合用时疗效增加，但动脉血氧饱和量和降低，导致ST段电压降低增加〔4〕。

10. 硝酸异山梨醇酯与异搏定

异搏定能减轻心脏后负荷，并扩张冠状动脉；硝酸异山梨醇酯主要扩张小静脉，减轻心脏前负荷。故二者合用时，能减轻心肌耗氧量，改善心肌供血状况，使疗效增加。对稳定型心绞痛的治疗，二者合用疗效增加。对劳力型心绞痛，二者合用可减少发作次数和严重程度，还能减少硝酸酯类药物的用量〔5〕。

11. 硝酸异山梨醇酯与硝苯吡啶

二者合用治疗心绞痛时，能降低体循环血管阻力，易使一些病人发生严重体位性低血压。如有人报道了10例顽固性心绞痛，使用了80~120mg/日硝苯吡啶，均合用了硝酸异山梨醇酯，全部都引起了低血压和心肌缺血恶化〔6〕。

12. 硝酸异山梨醇酯与硫氮䓬酮

硫氮䓬酮能减轻心后负荷，并扩张冠状动脉，与硝酸异山梨醇酯合用时，能松弛血管平滑肌，减轻心肌耗氧量，改善心肌供血状况。用于治疗变异型心绞痛有协同的作用，安全有效，并能减少硝酸酯类药物的用量。二者合用于劳力型心绞痛时，可减少发作次数，改善运动能力，延长诱发心绞痛作时间。

13. 硝酸异山梨醇酯与奎尼丁

奎尼丁也具有血管扩张作用，二者合用时，血管扩张作用加强，能引起严重的体位性低血压。

14. 硝酸异山梨醇酯与普鲁卡因酰胺

普鲁卡因酰胺具有血管扩张作用，尤其静脉注射，血管扩张作用更为显著，如与硝酸异山梨醇酯合用，这一作用更为加强，易致严重的体位性低血压。

15. 硝酸异山梨醇酯与苯妥英钠

苯妥英钠能促进硝酸异山梨醇酯在肝内的代谢和灭活,二者合用时,抗心绞痛作用显著减弱。

16. 硝酸异山梨醇酯与普罗帕酮

二者分别使用时,有些病人即可引起头晕的症状,二者合用时,症状加重^[7]。

17. 硝酸异山梨醇酯与利血平

硝酸异山梨醇酯能增加利血平的降血压作用,二者合用时,致血压过低,故应慎重。

18. 硝酸异山梨醇酯与胍苯哒嗪

二者合用时,可致严重的低血压反应,并能降低硝酸异山梨醇酯的抗心绞痛作用,故二者合用有害。这一现象与增加心率和心肌耗氧量有关。

19. 硝酸异山梨醇酯与甲基多巴

甲基多巴通过与脑干受体结合,产生外周性交感神经抑制作用,使血压下降。与硝酸异山梨醇酯合用时,降压作用加剧,可致严重的低血压。

20. 硝酸异山梨醇酯与哌唑嗪

二者合用治疗急性、慢性心力衰竭均具有良好的疗效,对促进利尿也有很好的作用。但二者合用可致低血压反应,要注意。

21. 硝酸异山梨醇酯与硫甲丙脯酸

实验证明,硫甲丙脯酸能增加硝酸异山梨醇酯的效应,对治疗缺血性心脏病有良好的作用。这可能与巯基参与相互作用有关,与血管紧张素转换酶抑制剂的性质无关^[8]。

22. 硝酸异山梨醇酯与利尿剂

硝酸异山梨醇酯与双氢克尿塞、速尿、安体舒通、氨苯喋啶等药合用时,利尿作用和降压作用均加强。

23. 硝酸异山梨醇酯与肾上腺素等

硝酸异山梨醇酯的扩血管作用,可对抗肾上腺素、去甲肾上腺素的升压作用,在抢救休克时,二者不宜合用。

24. 硝酸异山梨醇酯与氨茶碱

氨茶碱具有兴奋心肌的作用,增加心肌收缩力,扩张周围血管,增加肾血流量,扩张支气管平滑肌,改善通气,与硝酸异山梨醇酯合用时,二者具有协同作用,对治疗肺心病肾衰有良好的疗效,副作用少,并能减少硝酸酯类的用量^[9]。

25. 硝酸异山梨醇酯与吗啡

硝酸异山梨醇酯能迅速解除吗啡引起的胆道和输尿管平滑肌痉挛,消除阿狄氏括约肌痉挛所致的胆道压力升高。

26. 硝酸异山梨醇酯与乙醇

二者呈协同的血管扩张作用,能引起血压下降,昏厥等不良反应,并且还可导致胃肠道不适。

参 考 文 献

1. 徐永昭. 血管扩张剂与其他药物的相互作用. 中华护理杂志 1983; 23(3): 164.
2. 马德赞. 抢救心衰的合并用药1986; 6(4): 209.
3. 黄素玉. 抗心绞痛药物的联合应用. 河北医药 1989; 11(3): 174.
4. Tirlapur VG, et al. Cardiorespiratory effects of isosorbide dinitrate and nifedipine in combination with nadolol. A double-blind comparative study of beneficial and adverse antianginal drug interactions. Am J Cardiol 1984; 53: 487.
5. Franciosa JA, et al. Immediate effects of hydralazine isosorbide dinitrate combination on exercise capacity and exercise hemodynamics in patient with left ventricular failure. Circulation 1979; 59: 1085.
6. 蔡怀林. 硝苯吡啶引起顽固性心绞痛及心肌缺血. 国外医学内科学分册 1986; 13(4): 184.
7. 金慕正. 普罗帕酮的临床药理和临床应用. 新药与临床 1988; 7(2): 114.
8. 孙宏. 硫甲丙脯酸增强消心痛引起的冠脉扩张. 国外医学药学分册 1988; 15(3): 182.
9. 方俊岚, 等. 消心痛、氨茶碱合用治疗肺心病肾衰. 中国初级卫生保健 1987; (11): 22.

冯同分 赵明 (沈阳军区司令部门诊部) 来稿报道临床中所遇罕见畸形第三磨牙2例。例1为右上颌第3磨牙, 牙冠较小, 颌面已开扩, 髓腔内有异味, 为融合牙。例2为左下颌舌向位阻生第三磨牙。二例均经2%奴夫卡因注射剂阻滞麻醉, 例2拔除困

难, 采用去骨法全部摘除。

离体牙实体观: 牙冠发育过小, 冠似双尖牙, 根端似鱼尾状 呈圆凸形。X线片正面示髓腔呈△型, 根管不清, 佳面观据部呈弧型, 围绕牙根颈部形状如鱼尾。